

小儿肺炎诊疗指南

一、疾病定义与病因

1.1 疾病定义

小儿肺炎是指不同病原体（细菌、病毒、支原体、真菌等）或其他因素（如吸入羊水、过敏反应）所引起的肺部炎症。它是婴幼儿时期最常见的严重呼吸道疾病，也是导致 5 岁以下儿童死亡的主要原因之一。临床上以发热、咳嗽、气促、呼吸困难及肺部固定湿啰音为主要表现。

1.2 主要病因

小儿肺炎的病因复杂，根据感染病原体的不同，主要分为以下几类：

分类	常见病原体	特点
病毒性肺炎	呼吸道合胞病毒（RSV）、腺病毒、流感病毒、副流感病毒	婴幼儿最常见，冬春季高发，起病急，中毒症状重，需抗病毒治疗。
细菌性肺炎	肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、流感嗜血杆菌、大肠杆菌	起病急，中毒症状重，需抗生素治疗。
支原体肺炎	肺炎支原体	学龄儿童多见，刺激性干咳，肺部体征不明显。
真菌性肺炎	白色念珠菌、曲霉菌	多见于免疫力低下、长期使用广谱抗生素的患儿。
吸入性肺炎	羊水、胎粪、乳汁、异物	新生儿或喂养不当的婴儿常见，起病急，病情重。

诱发因素：早产、低出生体重、先天性心脏病、营养不良、维生素 D 缺乏、居住环境拥挤、空气污染、被动吸烟等。

二、典型症状与体征

2.1 主要症状

- 发热：体温可达 38℃-40℃，热型不定。新生儿或体弱儿可能体温不升，仅表

现为低体温。

- 2. **咳嗽**：初期为刺激性干咳，极期咳嗽加重，恢复期转为湿咳有痰鸣。支原体肺炎表现为顽固性剧烈干咳。
- 3. **气促与呼吸困难**：呼吸频率增快（<2 个月 ≥ 60 次/分，2-12 个月 ≥ 50 次/分，1-5 岁 ≥ 40 次/分），可见鼻翼扇动、三凹征（吸气时胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙凹陷）。
- 4. **发绀**：口周、指甲床出现青紫色，提示缺氧严重。
- 5. **全身症状**：精神萎靡、食欲减退、烦躁不安，重症可出现嗜睡或惊厥。

2.2 典型体征

- **肺部听诊**：早期呼吸音粗糙，极期可闻及**固定性中细湿啰音**（以背部及脊柱两侧明显）。
- **叩诊**：病灶范围较大时可呈浊音。
- **重症体征**：心率增快（>160-180 次/分）、肝脏进行性增大、心音低钝，提示心力衰竭。

三、诊断标准与检查方法

3.1 诊断标准

符合以下任意一项即可临床诊断肺炎：

- 1. 发热、咳嗽、气促的典型症状 + 肺部固定湿啰音。
- 2. 胸部 X 线检查显示肺部点状、斑片状或大片状浸润阴影。

3.2 辅助检查

检查项目	目的与临床意义
血常规	细菌感染时白细胞总数和中性粒细胞比例升高；病毒感染时白细胞正常或偏低。
C 反应蛋白 (CRP)	细菌感染时显著升高 (>30mg/L)，支原体轻度升高，病毒性正常或轻度升高。
降钙素原 (PCT)	严重细菌感染的敏感指标，>0.5ng/mL 提示细菌感染。

检查项目	目的与临床意义
病原学检查	痰培养、血培养、鼻咽拭子抗原检测（如流感病毒、RSV）、支原体抗体 IgM。
胸部 X 线	诊断金标准。可见肺纹理增粗、小斑片状浸润影（支气管肺炎），或大片状均匀致密性肺炎）。
血气分析	重症患儿评估缺氧程度和酸碱失衡。

四、治疗方案（包括常用药物）

4.1 一般治疗

- 保持室内空气流通，温度 18-20℃，湿度 60% 为宜。
- 保证充足液体摄入，少量多次喂奶或饮水，防止脱水。
- 翻身拍背、体位引流，促进痰液排出。
- 缺氧者给予鼻导管吸氧（维持血氧饱和度 >95%）。

4.2 抗感染治疗（核心用药）

4.2.1 抗生素治疗（细菌性肺炎、支原体肺炎）

病原体/类型	首选药物	替代药物	疗程
肺炎链球菌	阿莫西林 / 青霉素 G	头孢曲松、头孢噻肟	7-10 天
金黄色葡萄球菌	苯唑西林 / 头孢呋辛	万古霉素、利奈唑胺	14-21 天
流感嗜血杆菌	阿莫西林克拉维酸钾	头孢克肟、阿奇霉素	7-10 天
肺炎支原体/衣原体	阿奇霉素（10mg/kg/天，连用 3-5 天）	克拉霉素、红霉素	10-14 天

用药原则：轻症口服，重症静脉给药；热退后 3-5 天且临床症状明显好转时，可由静脉转为口服序贯治疗。

4.2.2 抗病毒治疗

- **流感病毒：**奥司他韦（发病 48 小时内使用效果最佳）。
- **呼吸道合胞病毒（RSV）：**利巴韦林雾化吸入（重症考虑）。
- 普通病毒性肺炎以对症支持治疗为主，**不常规使用抗生素**。

4.3 对症治疗

- **退热：**体温 $>38.5^{\circ}\text{C}$ 时口服布洛芬（5-10mg/kg）或对乙酰氨基酚（10-15mg/kg）。
- **祛痰止咳：**氨溴索口服液、乙酰半胱氨酸雾化吸入。**避免使用强力镇咳药**（如可待因），以防痰液堵塞气道。
- **平喘：**沙丁胺醇雾化吸入（合并喘息时）。
- **雾化吸入：**布地奈德 + 异丙托溴铵，每日 1-2 次，减轻气道炎症。

4.4 重症肺炎处理

若出现心力衰竭、呼吸衰竭、中毒性脑病等并发症，需立即住院治疗，给予强心（地高辛）、利尿（呋塞米）、血管活性药物（多巴胺）及呼吸机辅助通气。

五、家庭护理与预防建议

5.1 家庭护理要点

1. **环境管理：**勤开窗通风，避免烟雾、油烟、香水等刺激性气味。
2. **拍背排痰：**手掌呈空心状，由下向上、由外向内轻拍患儿背部，餐前 1 小时或餐后 2 小时进行，每次 5-10 分钟。
3. **饮食调理：**给予易消化、高营养的流质或半流质食物（如米汤、菜泥、蛋羹），避免过甜、过咸、油腻食物。
4. **病情观察：**密切关注体温、呼吸频率、精神状态。若出现拒食、嗜睡、呼吸急促加重、口唇发紫，**立即就医**。
5. **遵医嘱用药：**抗生素必须足量、足疗程使用，**不可自行停药或减量**，以免产生耐药或复发。

5.2 预防措施

1. **疫苗接种**：按时接种肺炎链球菌结合疫苗（PCV13）和 流感嗜血杆菌疫苗（Hib），每年秋季接种流感疫苗。
2. **增强体质**：保证每日户外活动 1-2 小时，适当进行耐寒锻炼（如冷水洗脸）。
3. **营养支持**：提倡母乳喂养至少 6 个月，及时添加辅食，补充维生素 AD 滴剂。
4. **避免交叉感染**：肺炎高发季节少去人多拥挤的公共场所，家人感冒时佩戴口罩并隔离接触。
5. **手卫生**：培养儿童勤洗手习惯，有效减少病原体传播。

特别提醒：本指南仅供医学知识科普和 RAG 系统测试使用，不可替代专业医生的诊断与治疗。若儿童出现疑似肺炎症状，请务必及时前往正规医疗机构就诊。

 **如何保存为 PDF 文件？**